

Acht par VB.

① Gefacet 1g cp

1cp 3x jr

(Q&P 7jrs)

② Doliprane cp 1g

1cp 2x jr

(01kte)

③ Triperfol cp

1cp 2x jr

(02kte)

④ phylant cp

1cp 2x jr

(04kte)

⑤ bivenax 0,4cc inj

(03kte)

0,1 inj / jr en S/C

⑥ Saporelle lotion

1app 3x jr

(01fe)

→ Post op:

1/ Cefacet cp 1g
01 cp 2x jr

(26te

2/ Gentam Amp 80mg
01 inj/en IM

(QSP 5 jrs

3/ Bovenox 0,4cc inj
01 inj/jr en S/c

(036te

4/ Frisefol cp
01 cp 2x jr

(026te

Nné =

- (1) Eosine aqueuse lotion (01 flc)
01 app 2xjr
- (2) Compresse sterile (01 lte)
- (3) Vit D₃ amp (01 lte)
01 amp / mois
- (4) Rifamycine collyre (01 flc)
01 gtt / œil 2xjr
- (5) Lait 1^{er} âge / lait pré-mat

Pré-eclampsie :

↑ TA + Prot > 3g / 24h (> +++ CU)

⇒ recherche : DMI

- ↑ urée : 350 μmol/L (souffrance placentaire)
- f(x) hépatique
- Thrombopénie
- RCIU (dosage ACUSCA)

Pré-Eclampsie Sévère :

TA > 16/11

dir plu + Vmt

Céphalée

Prot > 3,5 g/L
de 24h

oligurie, creat > 100 μmol/L

thrombopénie < $100 \cdot 10^3$

cytolysé hépatique : 3 x norme.

Menace d'ABRT:

- ① Utrogestan ovule 01 ovule/jr la nuit (01^{ste})
- ② progesterone inj 01 inj/jr la 1^{ère} 1^{ste}
01 inj/3 jr la 2^{ème} 2^{ste}
01 inj/semaine la 3^{ème} 3^{ste}

Eclampsie:

- ① Sulfate de Mg^{2+} 4g / 20 min
+ Appel Réa

Exagérat° des sympt

➤ ? EG + E. hydratation

➤ Bilan si nécessaire =

- FNS, ions

- β -HCG.

- TSH ; T_3 ; T_4

➤ trt = 1/ Azantac amp 0.2 x jr

2/ largactil 5B

05 gtt le soir

3/ lamac 20mg/gel

2 gel / jr

ABRT en Cours:

① Methergin gtt (0.5 flc)

15 gtt 3xjr

② Ferrosenol gyn gel (0.25 flc)

0.1 gel 2xjr

⚠ si HTA. CI au Methergin

⇒ Synto

Regles Abondantes:

① Dicynon cp (0.1 flc)

2cp 3xjr

② Ferrosenol gyn gel (0.25 flc)

0.1 gel 2xjr

+ Bilan = BHGG + FNS

➤ si jaunāte:

① Vibramy cine cp 100mg
0.1cp 1xjr

② Rovamycine 500mg

③ Saforelle sol 3xjr
0.4cp /jr (QSP 4jr)

si Transparente:

① Rovamycine cp
1cp 2xjr

(QSP 10jr)

② Saforelle sol